EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	Nº EGRESO	:	73697
SERVICIO	:	MEDICINA HSC			
FECHA	:	2023-11-07 11:16:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: NORKA FLOR PARRA VERGARA			RUN	: 9.513.803-9
F.Nac	: 08-05-1961	Edad	: 62 AÑOS, 5 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: VICUNA MACKENNA 788			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA A	Teléfono	: 99722841		
Fecha Ingreso	: 2023-11-02	Fecha Egreso	: 2023-11-07 11:16:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I61.9-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

- HIC talámica-capsular izquierda ICH 1, Día 13. Obs HTA
- Hipertensión arterial

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I61-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Femenina de 62 años. mRS 0,trabaja como modista. AM: HTA.
El día 25/10/23 a las 12:37 hrs consultó en hospital de San Carlos por cuadro de cefalea de 30 minutos de evolución asociado a disartria, desviación de la mirada hacia la izquierda y hemiparesia braquiocrural derecha, ingresa con compromiso de conciencia, vómito explosivo asociado a emergencia hipertensiva 220/100 mmHg, se administra Labetalol 20 mg EV. TAC de cerebro s/c a las 13:32: Hemorragia talámica izquierda con vaciamiento al 3er y 4to ventrículo. Es trasladada desde H. San Carlos por ACV hemorrágico con manejo activo de PA (Bic Urapidilo), apoyo ventilatorio naricera 2lts.
Ingresa al SU del HHM 13:52 hrs se objetiva PA 148/77 mmHg, afebril, FC 47 lpm por lo que se administra Atropina 0.5 mg EV, se hospitaliza en TIM MQ. TAC s/c 26/10 evidencia hematoma parenquimatoso tálamo capsular izquierdo de similar tamaño y efecto masa. Evoluciona estable, sin deterioro. al 5to día de evolución , en condiciones de traslado a sala común, se rescata al servicio de Neurología , sala 6. Mantiene focalidad sensitivo motora marcada a derecha, en etapa de rehabilitación. Se solicita traslado a HSC. en HSC progresa de forma favorable, se logra retiro de SNG y buena tolerncia a la alimentación con régimen liviano. En cuanto a lo kinésico logra prograsar a bipedestación con asistencia máxima de un operador.
En cuanto a lo neurológico se mantiene con buena tolerancia al esquema antihipertensivo y sin fluctuación neurológica por lo que se conversa con familiar responsable y se acuerda en conjunto alta hospitalaria para seguimiento ambulatorio.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido, semisentado, contención SOS, O2 SOS , PUPP
2. Régimen liviano hiposódico. Agua 300 cc 3v/d
3. Losartán 50 mg c/12h por vo
4. Hidralazina 50 mg c/8h por vo
5. Amlodipino 10 mg día por vo
6. Metildopa 250 mg 2c/8h por vo
7. Atorvastatina 40 mg/día por vo
8. Lactulosa 20 ml noche por vo
9. Omeprazol 20 mg al día VO
10. Kinesioterapia motora
11. Fonoaudiología
12. Control en CAE HSC neurología
13. Control en caso de necesidad en servicio de urgencias. Se explican situaciones de reconsulta.

EXÁMENES Y RESULTADOS

- 06/11 AngioTC de cerebro y cuello, sin alteraciones vasculares, hematma estable en relación a control previo, sin hidrocefalia.
- 03/11 Glic 102 Crea 0.8 MDRD 72.68 Uremia 81 Na 140 K 4.3 Cl 104 Leu 9800 Hb 13.7 Plaq 288000 Seg 72 VHS 24 PCR 37.1 Lact 0.7 ColT 98 HDL 47 LDL 34 VLDL 17.4 TG 87 FA 1.59 BI 1.59 BD 0.01 BT 1.6 GOT 27 GPT 36 GGT 30 INR 1.12 TTPA 28 TSH 1.528
- 29/10 Hb/Hcto 13.2/39.6, PLQ 217.000, Leucocitos 9.090, PCR 18.1
- 28/10 PCR 22.5 mg/L, Creatinina 0.78 mg/dL, Leucocitos 11.9, Hb/Hcto 12.9/38.8, K 3.3 Na 137.
- 26/10 TC de encéfalo sin contraste: : Hematoma parenquimatoso tálamo capsular izquierdo de similar tamaño y efecto masa
- 25/10 Grupo O Rh (+), pH 7.36 , pCO2 40.3, HCO3 22.4
- 25/10 TC de encéfalo sin contraste: Hemorragia talámica izquierda con vaciamiento al 3er y 4to ventrículo
- Rx de tórax: sin infiltrados ni imágenes de condensación. OC

OBSERVACIONES:

Ex neurológico
- Mental: vigil,orientada en tiempo y espacio, sin alteración de lenguaje, disartria leve
- NC: pupilas isocoricas, RFM +/+, CV normal, OCM normal. Sensibilidad facial disminuida hemicara derecha, PFC derecha, resto sin alteraciones.
- Motor hemiparesia hipotónica derecha brquial M0, Crural M0-1. ROT presentes plantar extensor derecho

- Sensitivo: hipoestesia táctil 20% FBC derecha
- Cerebelo: conservado a izquierda,
- Signos meningeos(-)

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
MEDICO TRATANTE
16447719-3

JEFE SERVICIO